

12주차 2교시. 청소년과 정신건강

1. 정신건강의 개념과 청소년기 정서

1) 정신건강의 개념

- 인간의 삶에 행복과 불행을 좌우하는데 있어서 정신건강은 매우 중요하다.

(1) 세계보건기구

- 건강이란 신체적·정신적 및 사회적으로 완전한 안녕의 상태로서 단지 지병이 없거나 허약하지 않은 상태를 말하는 것은 아니다. 건강은 한 인간 생활의 모든 측면의·식·주, 노동, 인간관계 및 사회생활 등과 밀접한 관계가 있으며, 개인의 정서적 균형, 정신적 구조의 외부환경에의 적응은 물론 사회생활을 영위해 나갈 수 있는 능력을 포함하고 있다.

(2) 미국정신위생위원회

- 정신건강이란 정신적 질병에 걸려 있지 않은 상태만이 아니고 만족스러운 인간관계와 그것을 유지해 나갈 수 있는 능력을 나타낸다. 이것의 의미는 모든 종류의 개인적·사회적 적응을 포함하며 어떠한 환경에도 대처해 나갈 수 있는 균형 있고, 건전하며, 통일된 성격을 발달시킨다는 것을 의미한다.

(3) 미국정신의학회

- 정신적 질환을 예방하고 초기 치료를 통하여 정신질환을 감소시키며, 정신건강을 유지하고 증진시키는 방법으로 정의한다.

2) 정신건강의 기준

- ① 성취동기 : 개인을 정신적·육체적으로 건강하게 발달시켜, 주어진 과제를 수행하도록 동기화한 상태를 말한다.
- ② 정서적 균형 : 자신의 감정을 통제할 수 있다는 것을 의미한다.
- ③ 인지적 기능 : 정신적으로 건강한 개인은 외부세력에서 일어나고 있는 내용이나 자신의 심경이 어떠한지를 올바르게 인지하고 있는 것이다.
- ④ 사회적 적응 : 타인에게 이성적 행동을 할 수 있고 때로는 자기 방어적이기도 하며 상호적 관계와 박애적인 신념을 가질 수 있는 능력을 말한다.

3) 청소년기 정서

- 청소년기는 아동기와 다른 정서적 특징을 보인다.
 - ① 청소년들의 정서는 격렬하고 쉽게 동요하는 속성이 있다.
 - ② 대체로 대인관계 문제가 정서를 자극하고 있다.
 - ③ 청소년이 되면 정서가 외부에 표출되기 보다는 내부에 숨겨진다거나 방어기제에 의해 변화된다든가 하여 외부에서는 쉽게 알 수 없게 된다.
 - ④ 청소년들의 정서적 변화에 영향을 미치는 요인은 신체·생리적 변화와 심리사회적 변화가 있다.
 - ⑤ 청소년들은 부모나 교사로부터의 주의나 관심으로부터 이탈하려는 경향이 있다.
- 청소년기에 가장 많이 제기되는 정신건강문제는 우울장애, 자살, 학교공포증 등이 있다. 우울장애는 다양한 요인에 의해 발생하게 되는데 무단결석, 약물남용, 가출, 비행 등의 문제로 나타나기도 하고 신체증상이나 성적 저하로 위장하여 우울증상이 ‘가면성 우울’을 나타내기도 한다.
- 자살 또한 심각한데 청소년들이 문제해결 방법으로 자살을 선택하고 있다는 점에서 관심이 요구되며 최근에 자살에 영향을 주는 것으로 또래집단의 학교폭력과 집단따돌림, 성적비관 등이 있다.
- 학교공포증은 가정에 애착을 가진 사람으로부터 분리되어 적어도 4주 동안 학교에 가는 것에 대해 과도한 불안을 가진 상태를 말한다.
- 청소년은 정신적 발달과정의 특성상 정상과 일탈, 준법과 불법 사이에서 떠다니는 불안정한 존재이기 때문에 그들에게 어떤 상황과 환경이 어떤 힘으로 작용하느냐가 매우 중요하다.
- 관심 있고 소질 있는 대상에 몰입하고 노력하는 신념이 강할수록, 학교나 공동체의 활동에 참여를 많이 할수록, 독서와 사색 그리고 대화를 통해 바른 신념을 굳건히 세울수록 험난한 청소년기의 표류상태에서 자기통제력을 키울 강한 원동력을 기를 수 있다.

2. 청소년 정신건강의 문제

1) 청소년기 스트레스

(1) 스트레스의 개념

- 스트레스는 성인뿐만 아니라 아동, 청소년 및 노인 등 전 연령대에서 나타난다.
- 스트레스는 스트레스를 일으키는 대상에 대한 생리적·정서적 반응으로 개인의 내적 균형 상태를 깨뜨려 스트레스 반응을 유발하는 상황 및 환경이다.
- 스트레스 반응은 위험한 상황에 처한 개체가 생존하게끔 하고 먹이를 잡을 때 효율을 높이는 데서 시작되었다.
- 스트레스란 인간이 환경에 잘 적응하고 변화하기 위한 기능이다
- 개인이 감당할 수 있는 적당한 수준의 스트레스는 활력과 자기계발, 건강증진에 도움을 준다.
- 스트레스를 과도하게 스스로 만들어내는 경우는 개인에게 정서적·정신적 문제를 일으킨다.
- 스트레스는 잘 관리가 되지 못하면 건강을 해치고 질병을 유발하는 요인이 된다.

(2) 청소년 스트레스의 원인

- 입시위주의 교육과 이로 인한 경쟁적이고 강박적인 학습 환경이 청소년 스트레스의 주된 원인이라는 사실은 익히 알려져 왔다.
- 뒤떨어지면 ‘큰일이 발생한다’는 위기감, ‘더 열심히 하지 않으면 안 된다’는 불안감은 작은 일에도 불안하고 긴장하게 하여 우리 몸이 견뎌내지 못하게 한다.
- 청소년 스트레스의 원인은 입시위주의 경쟁적인 환경에서 파생되는 성적, 진로와 직업, 외모, 경제적 어려움, 친구관계, 가정문제, 성문제 등 다양하다.

2) 청소년기 우울

(1) 청소년기 우울의 개념

- 우울은 기분이 저조한 상태로서 누구나 흔히 느끼는 감정 중의 하나이며 가볍게 느끼는 슬픔에서부터 심각한 우울증까지 나타내는 일반적인 용어이다.
- 청소년의 우울한 감정, 특히 경증에서부터 중증까지의 우울은 청소년기에 보편적으로 나타나는 현상이다.(Reynolds, 1995)
- 학업 및 일상생활에 심각한 장애를 가져오는 동시에 다양한 발달이 지속적으로 일어나야 하는 중요한 시기에 발달과정을 순조롭게 이행하지 못할 수 있으며 비행문제, 자살까지도 발생할 수 있기 때문에 적절한 시기의 도움이 필요하다.

- 청소년기의 우울은 발달상 특성으로 간주하여 일시적이며 시간이 지나면 해결될 것으로 생각하여 안이하게 대처하기 쉽다.
- 우울한 감정이 장기간 걸쳐 일어나고 심화되면 부정적인 자아개념, 일상활동에 대한 관심 및 흥미 저하와 의욕상실, 무기력감, 식욕저하, 주의집중 곤란, 수면장애 등의 심각한 장애들이 수반될 수 있다.
- 청소년기는 심리적·사회적으로 매우 불안정하고 청소년이 처한 환경과 상황은 청소년 자신의 존재가치와 역할에 대한 책임과 의무에 대하여 고민하게 되며, 자신의 미래에 대한 불안과 함께 현실을 도피하고자 하는 정서적 어려움에 처하게 된다.

(2) 청소년기 우울의 특징과 증상

[청소년기 우울증 주요 특징(Cantwell Baker, 1991)]

- ① 지속적으로 슬픈 감정을 보인다.
- ② 이전에 좋아하던 활동을 하지 않고, 활동 자체가 현저히 줄어든다.
- ③ 화를 잘 낸다.
- ④ 두통이나 복통과 같은 신체적 증상이 빈번히 나타난다.
- ⑤ 학교를 자주 결석하거나 성적이 저조하고 과제를 이행하지 않게 된다.
- ⑥ 주의집중력이 떨어지고, 권태감을 자주 호소한다.
- ⑦ 식사나 수면시간의 변화가 나타난다.
- ⑧ 친구들과 어울리는 시간이 줄어들고, 혼자 지내거나 친구들과의 놀이에 흥미를 잃는 경우가 많다.
- ⑨ 자살에 대해 이야기를 하거나, 죽고 싶다는 말을 한다.
- ⑩ 기분전환으로 알코올이나 흡연과 같은 약물남용에 빠지는 경우가 발생한다.

[청소년의 우울증 증상(White, 1989)]

- ① 정서·감정적인 측면 : 심각한 슬픔, 비애감, 의기소침, 좌절감, 낙심 등에 빠져 있으며, 감정의 기복이 심하고 화를 잘 내며, 신경질적이다.
- ② 인지·사고적인 측면 : 자아개념이 낮으며, 자기비하, 자기 비판적인 태도를 가지고, 극도의 죄책감과 수치감으로 휩싸이게 된다. 희망이 없으며 장래에 대한 계획이 부재하고, 삶의 가치가 없다고 생각하여 자살이나 죽음에 대한 생각을 하게 된다.
- ③ 행동적인 측면 : 무기력감에 빠져 있고, 무슨 일을 시작하지 못하거나 시도하지 않으며, 일에 집중하는 능력이나 활동에 참여하려는 의욕이 떨어진다. 특히 즐겨하던 사회활동으로부터 자신을 격리시키며, 일상생활에 대한 관심을 잃기 쉽다.
- ④ 신체적인 측면 : 극도의 피로감 내지는 쉽게 지치게 되고, 망각이 잦아진다. 식욕이 저하되거나 지나친 과식을 자주 하게 되고, 불면증으로 고생하거나 지나치게 잠을 많이 잔다. 그리고 두통, 복통, 또는 뚜렷한 증상 없이 자주 고통을 호소한다.

(3) 청소년기의 자살행동

① 자살행동의 개념

- 자살은 스스로 죽음을 선택하고 삶을 마감하는 것을 의미한다.
- 일반적으로 한 개인이 자살 실행으로 죽음에 이르는 것은 자살에 대한 생각과 계획, 시도 등 연속적인 과정의 결과이다.
- 청소년의 자살은 국내뿐만 아니라 다수 선진국에서도 청소년의 주요 사망원인이 되고 있다.
- 청소년은 발달과정상의 특성으로 인해 성인과는 다른 의도와 과정으로 자살행동을 시도한다.

② 자살행동의 구성요소

- 자살생각(Suicidal Ideation) : 죽고 싶다는 생각을 하는 것부터 자살과 관련된 행동을 시도하려는 생각을 의미한다.
- 자살계획(Suicidal Plan) : 자살생각의 수준을 넘어서 행동으로 표현되는 것으로 자해행동에 이르지 않는 유서작성, 소지품 정리를 포함한다.
- 자살시도(Suicidal Attempt) : 자해 등을 통해 죽기 위한 행동을 하지만 실제로 죽지 않는 경우를 말한다.
- 자살사망(Suicidal Completion) : 자살실행으로 죽음에 이르는 실제적 자살을 의미한다.

③ 청소년 자살행동의 특징

- 성인은 우울증, 정신분열증 등 정신병적 원인으로 자살행동을 시도하지만, 청소년은 인지적으로 미성숙하고 정서적으로 불안정하므로 충동성이나 회피적인 욕구에 의해 자살행동을 하는 경우가 많다.
- 소년의 자살시도는 성인에 비해 충동적이고 일시적이기 때문에 성공률이 낮다. 청소년자살이 생명을 완전히 포기하려는 의도보다 자신의 고통을 외부에 알려서 도움을 요청하고자 하는 표현으로 볼 수 있다.
- 청소년기는 또래집단이나 주변환경에 대한 모델링과 동일시를 추구하고 사회환경적 영향에 민감한 시기이다. 이러한 특성으로 청소년은 영향력 있는 사람의 죽음을 모방하거나 또래와 동반자살을 시도하는 특성이 있다.
- 청소년은 자살시도 방법이 면밀하지 못하므로 성인에 비해 자살로 사망할 확률이 높지 않다. 그러나 청소년후기나 성인기에 자살시도가 다시 재발될 가능성이 높기 때문에 청소년기의 자살행동 경험은 성인 자살의 중요한 위험요인이 된다.

3. 청소년 정신건강 문제 예방과 개입기관

1) 청소년 정신건강 문제 예방

(1) 청소년 스트레스 관리방안

- 같은 스트레스 상황에 노출되더라도 개인에 따라 스트레스를 받는 정도의 차이가 ‘자기조절력’에 따라 달라진다.
- 개인마다 스트레스원에 대하여 해석의 차이가 있고, 그 해석에 따른 반응이 각기 다르게 나타난다.
- 문제에 대한 인식을 긍정적으로 하는지, 부정적으로 하는지에 따라 스트레스 정도가 달라질 수 있다.
- 스트레스 관리에서 중요한 것은 ‘예측 가능성’과 ‘조절 가능성’이다.
- 앞으로 가야 할 길을 예측할 수 있게 조정하고, 능력에 맞추어 페이스를 조절하고, 현재 상황을 장악할 수 있다고 느낄수록 주관적으로 느끼는 스트레스는 훨씬 줄어들고 심리적·신체적 안정감은 커진다.
- 부모는 가정에서 청소년의 고민에 귀 기울이고, 친구와 같은 멘토로서 지지와 조언을 조절하여 제시하고, 방향으로 인한 어려운 시기를 가정이라는 울타리가 든든한 버팀목이 되어 줄 수 있다는 믿음을 주어야 한다.
- 교육환경은 청소년의 개성을 존중하고, 진로에 적합한 융합교육이 가능하도록 제도적·정책적 변화가 우선되어야 하며, 지나치게 서열화되고 성적으로 인정받는 사회 인식의 개선이 필요하다.

(2) 청소년 우울증 관리방안

- 청소년기 우울증은 몸과 마음을 동시에 병들게 하는 질환이다. 검사결과 특별한 소견이 없음에도 불구하고 두통, 복통, 현기증, 어지러움 등의 증상을 호소하기도 한다.
- 도움을 주려는 사람이 청소년들이 지니고 있는 건강한 면, 긍정적인 면을 인정하게 되면 청소년은 자신들이 힘겹게 지켜 가고 있는 건강한 부분을 스스로 인식할 수 있다.
- 청소년을 수동적으로 인식해 일방적으로 교정하려는 것이 아니라 부모와 학교, 지역 사회가 청소년을 치료 파트너로 여기고 함께 문제해결의 실마리를 찾으려고 노력해야 한다.
- 청소년기의 우울한 감정을 이해하기 위해서는 청소년과 대화를 시작하고, 청소년 편에 서서 본질적인 스트레스 원인이 무엇인지 찾아보려는 노력이 필요하다.

(3) 청소년 자살 관리방안

- 청소년은 죽음에 대하여 막연하고 불확실한 생각을 갖고, 현실의 고통을 회피하거나 절망, 분노, 상실에 대한 극단적 표현으로 자살을 시도하려 한다.
- 청소년의 자살은 자살행동으로 나아가기 전에 나타나는 징후가 있으며, 그러한 징후에 대하여 관심을 갖는다면 자살을 예방할 수 있다.
- 자신의 감정을 충분히 표현하고, 자신만의 스트레스 해소 방법을 찾아 우울하거나 부정적인 감정이 찾아올 때 탈출구로 나아가는 연습을 한다.
- 가정에서는 올바른 양육 태도와 일관성 있는 훈육으로 자녀가 규범을 지키고 자신의 감정을 절제하며 적절히 표현할 수 있도록 부모의 책임 있는 역할이 필요하다.
- 학교에서는 또래 상담자의 역할을 더욱 확대하여, 청소년기 고민을 해결하고 갈등을 조정하는 데 중요한 역할을 하도록 해야 한다.

2) 청소년 정신건강 분야 전문가

- 많은 건강전문인 집단이 정신건강문제를 경험하고 있는 대상자에게 서비스를 제공하기 위해 함께 일하고 있다.
- 이들의 전문영역은 다르지만 대상자에게 도움을 제공한다는 같은 철학과 이론적인 배경을 가지고 서로 협력하고 있다.
- 의사, 간호사, 심리학자, 사회복지사, 작업치료사 등이 함께 일하며 상호 보완관계를 유지하고 있다.
- 정신과 의사는 정신과 환자의 입·퇴원, 진단, 임상검사, 약물요법 등을 담당하고, 간호사는 사례관리, 건강교육, 약물관리 및 교육, 증상관리 등을 수행한다.
- 심리학자는 개인, 가족, 집단을 대상으로 정신요법과 심리검사, 평가를 실시하고 있다.
- 사회복지사는 대상자의 사회력을 조사하고, 사례관리, 집단 정신요법 진행, 재활을 위한 활동을 수행하고 있다.

3) 청소년 정신건강 관련기관

(1) 1차 예방기관

- 정신건강증진을 목적으로 하는 일차 건강관리기관인 보건소 및 보건지소, 보건진료소, 정신과 외래 및 응급실, 청소년 상담기관, 자살예방센터에서는 질병예방, 사회환경적 요인 관리, 위기중재, 결손가족관리, 가족관계 상담, 소년원 청소년 상담, 학교지지, 부모교육 및 훈련 등의 프로그램을 운영하고 있다.

(2) 2차 예방기관

- 정신과 의원 및 정신과 병동에서는 정신질환의 조기발견, 조기치료, 만성화 예방, 응급전화(1393), 24시간 응급실 운영, 개인 및 가족 상담 등의 서비스를 제공하고 있다.

(3) 3차 예방기관

- 3차 건강관리기관 중 정신보건센터는 보건소와 지역정신보건활동의 거점으로서 정신보건에 관한 지식의 보급·조사연구, 복잡 또는 곤란한 상담과 지도 그리고 보건소에 대한 기술지도나 연수 등의 역할을 수행하고 있다.
- 청소년정신보건센터와 서울시 건강증진센터에서는 청소년 유관기관 협력체계 구축 및 교육자료 개발, 정신건강 문제 조기발견 및 조기개입사업을 진행하고 있고, 홈페이지를 통한 자가 검진 및 온라인 캠페인을 시행 중이다.

4) 정신건강증진센터

- 아동과 청소년을 대상으로 진행되는 정신건강증진사업은 아동·청소년의 건강한 성장을 돕기 위해 정신건강 상담 및 약물복용 교육, 치료 연계, 사례관리, 집단 프로그램, 지역사회 자원연결 등의 사업으로 성인기 질환으로의 이행방지와 건강한 성장발달을 도모하고자 운영되고 있다.
- 학교를 기반으로 조기발견 체계를 구축하여, 최적기에 정신건강 문제에 대한 평가, 치료, 사례관리로 정서·행동 문제에 대한 해결과 또래관계 어려움의 문제 해결, 사회성 증진과 부모교육을 통한 아동청소년에 대한 이해 고취, 양육스트레스 해소 기회를 제공하여 보다 나은 양육환경을 조성할 수 있도록 도모하고자 한다.

■ 학습정리

1. 정신건강의 개념과 청소년기 정서

1) 미국정신위생위원회의 정신건강에 대한 정의

- 정신적 질병에 걸려 있지 않은 상태만이 아니고 만족스러운 인간관계와 그것을 유지해 나갈 수 있는 능력을 나타낸다. 이것의 의미는 모든 종류의 개인적·사회적 적응을 포함하며 어떠한 환경에도 대처해 나갈 수 있는 균형 있고, 건전하고, 통일된 성격을 발달시킨다는 것을 의미한다.

2) 청소년기의 아동기와 다른 정서적 특징

- 청소년들의 정서는 격렬하고 쉽게 동요하는 속성이 있다.
- 대체로 대인관계 문제가 정서를 자극하고 있다.
- 청소년이 되면 정서가 외부에 표출되기보다는 내부에 숨겨진다거나 방어기제에 의해 변화된다든가 하여 외부에서는 쉽게 알 수 없게 된다.
- 청소년들의 정서적 변화에 영향을 미치는 요인은 신체·생리적 변화와 심리사회적 변화가 있다.
- 청소년들은 부모나 교사로부터의 주의나 관심으로부터 이탈하려는 경향이 있다

2. 청소년 정신건강의 문제

- 청소년 스트레스의 원인은 입시위주의 경쟁적인 환경에서 파생되는 성적, 진로와 직업, 외모, 경제적 어려움, 친구관계, 가정문제, 성문제 등 다양하다.
- 청소년기의 우울은 발달상 특성으로 간주하여 일시적이며 시간이 지나면 해결될 것으로 생각하여 안이하게 대처하기 쉽다. 그러나 이러한 감정이 장기간 걸쳐 일어나고 심화되면 부정적인 자아개념, 일상활동에 대한 관심 및 흥미 저하와 의욕상실, 무기력감, 식욕 저하, 주의집중 곤란, 수면장애 등의 심각한 장애들이 수반될 수 있다.
- 청소년은 발달과정상의 특성으로 인해 성인과는 다른 의도와 과정으로 자살행동을 시도한다.

3. 청소년 정신건강 문제 예방과 개입기관

- 스트레스 관리에서 중요한 것은 '예측 가능성'과 '조절 가능성'으로 앞으로 가야할 길을 예측할 수 있게 조정하고, 능력에 맞추어 페이스를 조절하고, 현재 상황을 장악할 수 있다고 느낄수록 주관적으로 느끼는 스트레스는 훨씬 줄어들고 심리적·신체적 안정감은 커진다.
- 청소년 우울증 치료를 위해 도움을 주려는 사람이 청소년들이 지니고 있는 건강한 면, 긍정적인 면을 인정하게 되면 청소년은 자신들이 힘겹게 지켜 가고 있는 건강한 부분을 스스로 인식할 수 있다.

- 청소년의 자살은 자살행동으로 나아가기 전에 나타나는 징후가 있으며, 그러한 징후에 대하여 관심을 갖는다면 자살을 예방할 수 있다.
- 정신건강증진센터는 아동과 청소년을 대상으로 진행되는 정신건강증진사업을 통해 아동·청소년의 건강한 성장을 돕기 위해 정신건강 상담 및 약물복용 교육, 치료 연계, 사례관리, 집단 프로그램, 지역사회 자원연결 등의 사업으로 성인기 질환으로의 이행방지와 건강한 성장발달을 도모하고자 한다.